Advanced Search

ASKEP - CPPT (Chatarina Danik Wijayanti, , S.Farm., Apt)

## LIST REGISTRASI 16 OCT 2026

RAWAT INAP

Merak

No. RM Pasien

Nama Pasien

Cari Pasien  Reset

| No | Tgl Reg | No RM | Nama | Ruang | No. Reg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/16 | 00284571 | NGATIK | Merak | 020201202600010546002 |
| 2 | 2026/10/15 | 00008848 | ALFREEDA NIRWIRA KHARISMA | Merak | 020201202600010541001 |
| 3 | 2026/10/15 | 00331800 | SRI WAKHIDAH | Merak | 020201202600010530001 |
| 4 | 2026/10/14 | 00061527 | SRI SUMIYATI | Merak | 020201202600010492001 |
| 5 | 2026/10/14 | 00109480 | SUNARTI | Merak | 020201202600010503001 |
| 6 | 2026/10/14 | 00055650 | RAFID AGASTIA KUMARA | Merak | 020201202600010500002 |

## DATA PRIBADI PASIEN PER 16 OCT 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Registrasi | **020201202600010503001** | Jenis Kel./Gol.Darah | **Perempuan / TIDAK TAHU** |
| Tanggal Registrasi | **14-10-2026** | Sub Instalasi/Poli | **Merak** |
| No. RM / No. Ident | **00109480 / 3402125811630001** | Sub Divisi | **-** |
| Nama | **SUNARTI** | Kamar/No. Bed | **MERAK 314 / 14A** |
| Alamat | **JL JANTI KANOMAN RT.7, BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN** | Cara Bayar | **JKN Non PBI** |
| No. Telp. | **089634090927** | Alergi | **AMOXISILIN DAN AMPISILIN** |
| Tanggal Lahir | **18-11-1963 (62 th 10 bln 28 hr)** | Alergi Obat | |
| Agama | **ISLAM** | Nama DPJP | **dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM** |

## MENU

- **RESUME HISTORY (PROFIL RINGKAS MEDIS)**
- **BERKAS RM**
- **MATRIK HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL RADIOLOGI**
- **HISTORY HASIL PATOLOGI**
- **HISTORY HASIL PEMERIKSAAN LAIN**
- VIEW ASSESMENT AWAL
- RPPT & CPPT
- INTEGRATED NOTES
- DOKUMEN EKSTERNAL
- PLANNING - ( P )
  - EDUKASI PASIEN
- TRANSFER PASIEN

## RPPT & CPPT

INFORMASI DPJP

### INFORMASI DOKTER PENANGGUNGJAWAB PASIEN

List history warna merah menandakan status sudah Selesai Rawat Bersama

Show 5 entries

| JENIS DPJP | NAMA DOKTER | SUB KSM |
|---|---|---|
| **DPJP Utama** | **dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto , Sp.PD.,FINASIM** | |

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

LIST RPPT

### RENCANA PENATALAKSANAAN PASIEN TERINTEGRASI

Show 5 entries  Search:

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah | Kebutuhan Pasien dan Tujuan Terukur | Status Masalah | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-2026 23:45 | Perawat<br>*TATANG HENDRA KURNIAWAN, A.Md.Kep* | Kenyamanan (Mual (00134)) | -Selera Makan (1014) | Membaik | READONLY |
| 2 | 15-10-2026 07:41 | Dokter Spesialis<br>*dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM* | -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan | ---lanjut | Membaik | READONLY |
| 3 | 15-10-2026 07:41 | Dokter Spesialis<br>*dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM* | [-- | ---- | - | READONLY |

Showing 1 to 3 of 3 entries

First Previous 1 Next Last

RESUME TAGIHAN

### RESUME TAGIHAN SEMENTARA

| CARA BAYAR | TAGIHAN RS | TAGIHAN OBAT KRONIS | PERKIRAAN TARIF KLAIM | TARIF KLAIM |
|---|---|---|---|---|
| JKN Non PBI | 863,600 | 0 | K-4-17-I / 2,335,200 | - |



(http://instistream:3000) AKAN ()

LIST CPPT

# CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI

Filter by Tgl CPPT : dd-mm-yyyy / PPA : -- SEMUA -- / Nama PPA : -- SEMUA -- Cari Search:

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah | Hasil Asesmen Pasien dan Pemberi Pelayanan | Planning PPA | Instruksi PPA | Verifikasi DPJP | Implementasi | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2026 14:00:00 | Perawat<br>User Insert:<br>*EKA DESY RETNOSARI A.md.Kep*<br><br>User Update:<br>EKA DESY RETNOSARI A.md.Kep | **S:** pasien mengatakan batuk berdahak<br>**O:** Ku.sedang, Kes.CM<br><br>Tekanan darah: 113/67, Suhu tubuh: 36.2 C, Denyut nadi: Reguler/90 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 98%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>16/10/2026<br>GDP : 235<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Lekosit, Hasil: 4850/mm³ (3600 - 11000)<br>- Hematokrit, Hasil: 33.9% (35 - 47)<br>- Eritrosit, Hasil: 3.93juta/mm³ (3.70 - 5.40)<br>- Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- SGPT, Hasil: 23U/L (< 34)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)<br>- Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- Kalium (K), Hasil: 4.23mmol/L (3.5 - 5.5)<br>- Klorida (Cl), Hasil: 87.75mmol/L (95.0 - 105.0)<br><br>Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08)<br>- Pulmo tak tampak kelainan<br>- Besar Cor normal | **A:** Kenyamanan (Mual (00134))<br>**STATUS:** Membaik | **P:** -Monitoring Nutrisi (1160)<br>-Manajemen Mual (1450)<br>-Manajemen Medikasi (2380)<br><br>-Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advice dr. Edhi Sp.PD:<br>==========<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U ( Via Lisan Novorapid 3x10 unit) | **Instruksi:**<br>Monitor ku dan keluhan<br>Monitor TTV<br>Kelola terapi<br>Kelola diit siang | UNVERIFIED | 16-10-2026 10:14 | Ubah |
| 2 | 16-10-2026 07:45:48 | Dokter Spesialis<br>User Insert:<br>*dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM*<br><br>User Update:<br>dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM | **S:** SUDAH MEMBAIK<br>**O:** Tekanan darah: 137/80, Suhu tubuh: 36.5C, Denyut nadi: Reguler/106 kali/menit, Nafas: 20 kali/menit, SpO2: 99%, Skor nyeri null : 0 | **A:** -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br>**STATUS:** Membaik | **P:** - Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Inj Novorapid 3x8U ( Via Lisan Novorapid 3x10 unit) | **Instruksi:** LANJUT | VERIFIED | 16-10-2026 07:45 | Ubah |

(http://instistream:3000) AKAN ()

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah | Hasil Asesmen Pasien dan Pemberi Pelayanan | Planning PPA | Instruksi PPA | Verifikasi DPJP | Implementasi | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16-10-2026 07:00:00 | Perawat<br>User Insert:<br>*Novitriyanti SKEP.Ners*<br><br>User Update:<br>Novitriyanti SKEP.Ners | **S:** pasien mengatakan batuk berdahak<br><br>**O:** ku sedang kes cm<br><br>Tekanan darah: 137/80, Suhu tubuh: 36.5 C, Denyut nadi: Reguler/106 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 99%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>16/10/2026<br>GDP : 235<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Lekosit, Hasil: 4850/mm³ (3600 - 11000)<br>- Hematokrit, Hasil: 33.9% (35 - 47)<br>- Eritrosit, Hasil: 3.93juta/mm³ (3.70 - 5.40)<br>- Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- SGPT, Hasil: 23U/L (< 34)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)<br>- Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- Kalium (K), Hasil: 4.23mmol/L (3.5 - 5.5)<br>- Klorida (Cl), Hasil: 87.75mmol/L (95.0 - 105.0)<br><br>Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08)<br>- Pulmo tak tampak kelainan<br>- Besar Cor normal | **A:** Kenyamanan (Mual (00134))<br>**STATUS:** Menetap | **P:** -Monitoring Nutrisi (1160)<br>-Manajemen Mual (1450)<br>-Manajemen Medikasi (2380)<br><br>-Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advice dr. Edhi Sp.PD:<br>==========<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U ( Via Lisan Novorapid 3x10 unit) | **Instruksi:**<br>Monitor ku dan keluhan<br>Monitor TTV<br>Kelola terapi<br>Kelola diit pagi | UNVERIFIED | 16-10-2026 07:00 | Ubah |

(http://instti.streami:3000)AKAN ()

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah | Hasil Asesmen Pasien dan Pemberi Pelayanan | Planning PPA | Instruksi PPA | Verifikasi DPJP | Implementasi | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15-10-2026 20:00:00 | Perawat<br>User Insert:<br>*Anita Fajar Wati, S.Kep.Ners*<br><br>User Update:<br>Novitriyanti SKEP.Ners | **S:** pasien mengatakan batuk berdahak<br>**O:** Tekanan darah: 125/66, Suhu tubuh: 36.4 C, Denyut nadi: Reguler/95 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 95%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Lekosit, Hasil: 4850/mm³ (3600 - 11000)<br>- Hematokrit, Hasil: 33.9% (35 - 47)<br>- Eritrosit, Hasil: 3.93juta/mm³ (3.70 - 5.40)<br>- Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- SGPT, Hasil: 23U/L (< 34)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)<br>- Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- Kalium (K), Hasil: 4.23mmol/L (3.5 - 5.5)<br>- Klorida (Cl), Hasil: 87.75mmol/L (95.0 - 105.0)<br><br>Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08)<br>- Pulmo tak tampak kelainan<br>- Besar Cor normal | **A:** Kenyamanan (Mual (00134))<br>**STATUS:** Menetap | **P:** A: -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advice dr. Edhi Sp.PD:<br>==========<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U ( Via Lisan Novorapid 3x10 unit) | **Instruksi:**<br>Monitor ku dan keluhan<br>Monitor TTV<br>Kelola terapi<br>Kelola diit siang | UNVERIFIED | 15-10-2026 20:48 | Ubah |
| 5 | 15-10-2026 16:00:25 | Apoteker<br>User Insert:<br>*Nurul Ernawati S.Far., Apt.*<br><br>User Update:<br>Nurul Ernawati S.Far., Apt. | **S:** Pasien mengatakan mual berkurang<br><br>**O:** Tekanan darah: 106/53, Suhu tubuh: 36.5 C, Denyut nadi: Reguler/84 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 98%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br>A: -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advice dr. Edhi Sp.PD:<br>==========<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Inj Novorapid 3x8U | **A:** Restriksi efornas terkait nama waktu cara dan indikasi pemberian obat<br>**STATUS:** Menetap | **P:** Monitoring terapi dan efek samping obat | **Instruksi:** Edukasi obat yang diberikan | UNVERIFIED | Implementasi | Ubah |

(http://instti.streami:3000)AKAN ()

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah<br>Hasil Asesmen Pasien dan Pemberi Pelayanan | Planning PPA | Instruksi PPA | Verifikasi DPJP | Implementasi | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15-10-2026<br>14:00:00 | Perawat<br>User Insert:<br>*Azhara Fachriza A., A. Md. Kep A.md.Kep*<br><br>User Update:<br>Azhara Fachriza A., A. Md. Kep<br>A.md.Kep | **S:** Pasien mengatakan mual berkurang<br>**O:** Tekanan darah: 106/53, Suhu tubuh: 36.5 C, Denyut nadi: Reguler/84 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 98%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Lekosit, Hasil: 4850/mm³ (3600 - 11000)<br>- Hematokrit, Hasil: 33.9% (35 - 47)<br>- Eritrosit, Hasil: 3.93juta/mm³ (3.70 - 5.40)<br>- Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- SGPT, Hasil: 23U/L (< 34)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)<br>- Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- Kalium (K), Hasil: 4.23mmol/L (3.5 - 5.5)<br>- Klorida (Cl), Hasil: 87.75mmol/L (95.0 - 105.0)<br><br>Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08)<br>- Pulmo tak tampak kelainan<br>- Besar Cor normal | **A:** Kenyamanan (Mual (00134))<br>**STATUS:** Menetap | **P:** -Monitoring Nutrisi (1160)<br>-Manajemen Mual (1450)<br><br>A: -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advice dr. Edhi Sp.PD:<br>==========<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U | **Instruksi:**<br>Monitor ku dan keluhan<br>Monitor TTV<br>Kelola terapi<br>Kelola diit siang | UNVERIFIED | 15-10-2026 14:00 | Ubah |
| 7 | 15-10-2026<br>08:50:31 | Nutrisionis<br>User Insert:<br>*NISRINA ANDIKA NAHARANI A.Md.Gz*<br><br>User Update:<br>NISRINA ANDIKA NAHARANI A.Md.Gz | **S:** A: Verifikasi skrining Gizi lanjut Dewasa : beresiko malnutrisi, Skor 1 (Monev setiap 3 hari sekali)<br><br>Nafsu makan menurun, recall asupan <80%<br><br>Diagnosis:<br>- Vomitus Profuse ec dalam pelacakan<br>- DM dengan Hiperglikemia<br>- Riw. Hipertensi<br>- Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>**O:** Antropometri<br>BB : 60 kg<br>TB : 156 cm<br>IMT : 24,65 kg/m2<br>Status Gizi : Normal<br><br>Tekanan darah: 149/70mmHg, Suhu tubuh: 36.5C, Denyut nadi: Reguler/92 kali/menit, Nafas: 20 kali/menit, SpO2: 96%, Skor nyeri null : 0<br><br>Laboratorium Patologi Klinik (15-10-2026 08:19:14)<br>- Glukosa Darah Sewaktu (Stik), Hasil: 208mg/dL (< 200)<br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1) | **A:** D: Pembatasan asupan zat gizi Karbohidrat sederhana dan Natrium bd gangguan fungsi endokrin dan Hipertensi dd DM dengan Hiperglikemia (GDS, Hasil: 208mg/dL) , Hipertensi (Tekanan darah: 149/70mmHg)<br>**STATUS:** Menetap | **P:** I:<br>DIIT DIABETES MELLITUS RENDAH GARAM<br><br>Tujuan Diet : Memberikan asupan gizi sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien<br><br>Terapi diet<br>Bentuk : Makanan Lunak (ML)/BB<br>Jenis diet : DMRG<br>Rute : Oral<br><br>Kebutuhan E dan zat gizi :<br>E : 1776,64 kkal<br>P : 63,21 g<br>L : 53,13 g<br>KH : 251,24 g (55%)<br><br>Edukasi : Asupan makan sesuai kebutuhan dan diet pasien (3J)<br>Kolaborasi : Asupan makan, ketepatan diet dan daya terima makan pasien<br><br>M/E :<br>Monev : dilakukan 3H sekali<br>1. Asupan makan (80-110%)<br>2. Biokimia (sesuai rujukan normal)<br>3. Fisik/klinis (sesuai rujukan normal) | **Instruksi:**<br>Pesanan diet :<br>ML DMRG (BB)<br><br>Frekuensi:<br>makan utama 3x selingan 2x | UNVERIFIED | UNIMPLEMENTED | Ubah |

(http://instit.stream:3000)AKAN ()

| No | Tgl & Jam | PPA | Diagnosis/Masalah | Hasil Asesmen Pasien dan Pemberi Pelayanan | Planning PPA | Instruksi PPA | Verifikasi DPJP | Implementasi | MANAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15-10-2026 07:42:11 | Dokter Spesialis<br>User Insert:<br>*dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM*<br><br>User Update:<br>dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM | **S:** Sesuai hasil assesment awal<br>**O:** Sesuai hasil assesment awal | **A:** -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br>**STATUS:** - | **P:** - Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U | **Instruksi:** | UNVERIFIED | Implementasi | Ubah |
| | | | | **A:** [--<br>**STATUS:** - | **P:** | **Instruksi:** | UNVERIFIED | Implementasi | |
| 9 | 15-10-2026 07:00:00 | Perawat<br>User Insert:<br>*TATANG HENDRA KURNIAWAN, A.Md.Kep*<br><br>User Update:<br>Novitriyanti SKEP.Ners | **S:** pasien mengatakan lemas, mual pusing<br>**O:** KU: lemas, CM E4V5M6<br><br>Tekanan darah: 149/70, Suhu tubuh: 36.5 C, Denyut nadi: Reguler/92 x/Menit, Nafas: 20 x/Menit, SpO2: 96%, Skor nyeri : 0 (Tidak Nyeri)<br><br>R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin<br><br>15/10/2026<br>GDP : 208<br><br><br>Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49)<br>- Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5)<br>- Lekosit, Hasil: 4850/mm³ (3600 - 11000)<br>- Hematokrit, Hasil: 33.9% (35 - 47)<br>- Eritrosit, Hasil: 3.93juta/mm³ (3.70 - 5.40)<br>- Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000)<br>- Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- SGOT, Hasil: 39U/L (< 35)<br>- SGPT, Hasil: 23U/L (< 34)<br>- Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43)<br>- Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)<br>- Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.<br>- Kalium (K), Hasil: 4.23mmol/L (3.5 - 5.5)<br>- Klorida (Cl), Hasil: 87.75mmol/L (95.0 - 105.0)<br><br>Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08)<br>- Pulmo tak tampak kelainan<br>- Besar Cor normal | **A:** Kenyamanan (Mual (00134))<br>**STATUS:** Menetap | **P:** Diagnosis:<br>- Vomitus Profuse ec dalam pelacakan<br>- DM dengan Hiperglikemia<br>- Riw. Hipertensi<br>- Hiponatremia & Hipochlorida ringan<br><br>Advis dr Edhi Sp.PD<br>----------<br>- Inf NaCl 0.9% 20 tpm<br>- Inj Omeprazole 1A/12 jam<br>- Inj Metoclorpamid 1A/8 jam<br>- PO Antasida Syr 3x1<br>- PO Rebamipid 3x1<br>- Obat Rutin STOP dulu<br>- Inj Novorapid 3x8U | **Instruksi:**<br>Observasi keluhan pasien<br>Observasi KU dan Tanda vital pasien<br>Observasi tetesan infus<br>Kelola terapi obat<br>Kelola diit pagi | UNVERIFIED | 14-10-2026 23:58 | Ubah |

Show 10 entries

Showing 1 to 10 of 12 entries

First Previous 1 2 Next Last

FORM CPPT

+ Tambah CPPT Baru

Simpan CPPT

(http://finsti.stream:3000)AKAN ()